Número do processo: 0760609-14.2025.8.07.0016

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: TAISSE VIEIRA MACIEL

REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL

SENTENÇA

Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por TAISSE VIEIRA MACIEL, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco EMGALITY (Galcanezumabe 120 mg), registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS.

Narra a parte autora que (I) vem enfrentando sérias limitações em sua rotina em decorrência de quadro clínico de enxaqueca crônica refratária, doença neurológica que provoca crises intensas e recorrentes de cefaleia, muitas vezes acompanhadas de náuseas, vômitos, sensibilidade à luz e ao som, e que compromete de forma significativa sua qualidade de vida; (II) conforme demonstra o relatório médico assinado pelo dr. Jorge Luiz G. Souza, CRM-DF 11009, já se submeteu a diversos tipos de tratamentos medicamentosos e terapias convencionais, sem sucesso clínico; (III) os métodos anteriormente utilizados se mostraram ineficazes para o controle das crises, que se intensificaram em frequência e intensidade nos últimos meses, gerando impacto direto sobre suas atividades cotidianas, laborais e sociais; (IV) foi-lhe, então, prescrito o uso do medicamento EMGALITY (galcanezumabe) – imunobiológico aprovado pela ANVISA e indicado especificamente para a prevenção de crises de enxaqueca em pacientes que não respondem ao tratamento comum; (V) mesmo diante de sua condição financeira limitada, já adquiriu a primeira dose do medicamento no mês de junho, arcando com o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com

recursos próprios, justamente para não atrasar o início do tratamento e evitar novos episódios graves; (VI) a manutenção do tratamento se mostra inviável sem o suporte do Sistema Único de Saúde (SUS), diante do custo elevado e da natureza contínua da medicação; (VII) é hipossuficiente, sem condições financeiras de arcar com tal despesa mensalmente, o que coloca em risco a regularidade e efetividade do regime terapêutico prescrito; (VIII) o medicamento não está disponível na lista de fornecimento regular do SUS, sendo necessário o ingresso da presente ação para garantir judicialmente o fornecimento gratuito, nos termos da legislação vigente.

Fundamenta sua pretensão na jurisprudência.

Postula, por fim, a procedência do pedido e a condenação da parte ré ao pagamento dos encargos sucumbenciais.

Atribui à causa o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

Decisões de declínio de competência, IDs 240580561 e 240835424.

A parte autora apresentou emenda, destacando a sua hipossuficiência financeira, e que o custo anual do tratamento totaliza R$ 13.800,00, bem como promovendo a juntada de comprovante da negativa de fornecimento do medicamento, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ID 243483974.

Em contestação, ID 166490332, o Distrito Federal requereu a improcedência do pedido aduzindo: (I) a ausência de cumprimento do ônus probatório exigido pelo STF e pela existência de tratamento no SUS, o pedido autoral deve ser rejeitado, nos termos do decidido pelo STF nas teses de repercussão geral nº 6 e 1234; (II) a inexistência de vício no ato administrativo da CONITEC e Ministério da Saúde que decidiram pela não incorporação do medicamento pretendido no SUS, de modo que não é devida a intervenção judicial. Em caso de eventual procedência pugnou pela: (III) fixação de prazo razoável para cumprimento uma vez que será necessária a aquisição de medicamento; (IV) observância ao PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor e (V) condenação ao pagamento de verba honorária por apreciação equitativa. Juntou manifestação técnica da GESAU, ID 246311537.

O NATJUS/TJDFT elaborou a Nota Técnica ID 247856730, classificando a demanda como justificada com ressalvas.

Em réplica, ID 248656213, a parte autora contestou os argumentos defensivos da parte ré e reiterou os termos da inicial.

O Ministério Público, em manifestação final ID 254107037, oficiou pela procedência do pedido.

É o relatório. DECIDO.

O tema posto em questão é unicamente de direito, de forma que o julgamento antecipado da lide se impõe, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

I _ DO MÉRITO

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito.

Pretende a parte autora obter provimento jurisdicional que obrigue a parte ré a lhe fornecer o medicamento EMGALITY (Galcanezumabe 120 mg), que não consta na política pública do SUS.

A resolução da lide exige que se estabeleçam os limites de proteção ao direito à saúde invocado, como as ações públicas de saúde podem ser objeto da atuação do Judiciário e se, no caso em exame, a pretensão da parte autora é abrangida pelo direito à saúde tutelável pelo Poder Judiciário.

No julgamento conjunto dos Temas nº 6 (RE 566.471/RN) e nº 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos:

Tema 06

> *Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral):*
> ***1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.***
> *2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que*

preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos andomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Tem234:

> *4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.*
> ***4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.***
> ***4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.*** *4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.*

Da leitura dos trechos acima transcritos resta claro que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode interferir nas políticas públicas de incorporação de medicamentos, independente do custo.

Excepcionalmente, poderá haver determinação judicial de dispensação de fármacos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos (I) registro na ANVISA; (II) negativa administrativa de fornecimento; (III) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; (IV) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (V) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (VI) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e (VII) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Do registro na ANVISA

De acordo com o item 2.3 da Nota Técnica ID 247856730, o fármaco possui registro na ANVISA sob número 100330224, ativo até 07/2029.

Da incapacidade financeira

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento.

Da comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança

No(s) relatório(s) ID(s) 240577049 o(a) médico(a) assistente. Dr. Verônica Lisboa Beloni, CRM-DF 19257, da Clínica Atennuar, atestou a imprescindibilidade do medicamento, bem como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos padronizados pelo SUS.

De outro lado, no item 1.6 da Nota Técnica ID 247856730, os profissionais técnicos do NATJUS apresentaram o seguinte resumo da histórica clínica do paciente:

> 1.6. Resumo da história clínica:
> Conforme relatório médico (ID 240577049) emitido em 17/06/2025 pela médica neurologista Dra. Veronica Lisboa Beloni (CRM-DF 19.257), trata-se de paciente portadora de migrânea crônica de difícil controle, cursando com cefaleia diária com crises intensas e incapacitantes associadas a fotofobia, fonofobia, náuseas, vômitos e vertigem. Informa que o quadro é complicado pelo uso excessivo de analgésicos, triptanos, miorrelaxantes e opioides.
> Já fez uso de diversas medicações profiláticas como amitriptilina, topiramato, propranolol, venlafaxina e valproato de sódio, sem eficácia adequada. Além das medicações, faz aplicações de toxina botulínica e bloqueio dos nervos occipital maior bilateral. Apesar de todo o tratamento, persiste com crises intensas diárias e muita incapacidade.
> Indica tratamento com anticorpo monoclonal contra o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) – galcanezumabe. Informa já ter feito aplicação de 01 dose, com melhora da dor. A duração do tratamento deve ser de pelo menos 12 meses.

E, ao final, após a análise da documentação médica apresentada, das opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, da literatura médico-científica, do posicionamento das principais sociedades

e agências de saúde, dentro outros elementos, emitiram conclusão **FAVORÁVEL COM RESSALVAS ao pedido**, tecendo as seguintes considerações:

> 8. CONCLUSÕES:
> Considerando que a paciente apresenta diagnóstico de cefaleia do tipo enxaqueca crônica refratária a inúmeros fármacos, segundo relatório médico acostado;
> Considerando tratar-se de quadro de crônico e de difícil manejo, com a utilização de diversos tratamentos prévios com medicamentos recomendados nas diretrizes, porém sem eficácia no controle da dor;
> Considerando que além da terapêutica medicamentosa, a paciente já fez uso de toxina botulínica e bloqueio de nervos occipitais, também sem resposta adequada;
> Considerando que há evidência científica de moderada qualidade para a eficácia do uso do galcanezumabe na enxaqueca crônica, no entanto com potencial efeito benéfico modesto (redução de 1,1 dias na enxaqueca episódica e 2,2 dias na enxaqueca crônica mensal);
> Considerando que o galcanezumabe é recomendado como uma opção para prevenir a enxaqueca em adultos quando, além da frequência, o autor tiver usado pelo menos 3 tratamentos medicamentosos preventivos e eles falharem;
> Considerando que agências internacionais, como a NICE e a CADTH, recomendam o uso de galcanezumabe exclusivamente para cefaleia enxaquecosa refratária e obedecendo critérios de elegibilidade, incluindo cumprimento de acordo de redução de preço;
> **Este NATJUS conclui por manifestar-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, uma vez que foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, no entanto, deve-se ponderar a dimensão dos benefícios obtidos (diminuição de apenas 2 dias por mês nos quadros de dor em relação ao placebo) com o tratamento demandado ante o seu alto custo e a falta de uma avaliação de custo-efetividade no contexto brasileiro.**

Da ausência de manifestação da CONITEC e da negativa administrativa da SES/DF

Conforme item 5 da Nota Técnica ID 247856730, a CONITEC não avaliou o uso de galcanezumabe na cefaleia enxaquecosa crônica.

Ademais, no documento ID 243483981, a SES/DF indeferiu o pedido aduzindo, em síntese, a não incorporação ao SUS.

Dentro desse contexto, principalmente considerando (I) a finalidade não curativa; (II) o alto custo anual (mais de R$ 25.000,00, conforme PMVG); (III) os discretos benefícios esperados (redução de 02 dias por mês em relação ao placebo); (IV) a sobrecarga do Sistema Único de Saúde e (V) o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, previsto no artigo 7º da Lei 8.080/90, reputo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da omissão da CONITEC.

Conclui-se, portanto, que o ato administrativo de negativa de dispensação guarda conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. Assim, não há como se falar em intervenção judicial na política pública de assistência à saúde.

Com efeito, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da existência de opções terapêuticas mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, <u>impactando negativamente no direito à saúde de todos os demais usuários.</u>

Se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao réu que forneça medicações a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar (significa!) deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência.

Nesse sentido, transcrevo a seguir a ponderação feita pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no artigo *"Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial"*, disponível na Biblioteca Digital do Tribunal de Minas Gerais, no endereço eletrônico https://bd.tjmg.jus.br/items/aaf1107e-1b83-4464-9a75-421d949f03b3:

> "(...) Alguém poderia supor, a um primeiro lance de vista, que se está diante de uma colisão de valores ou de interesses que contrapõe, de um lado, o direito à vida e à saúde e, de outro, a separação de Poderes, os princípios orçamentários e a reserva do possível. **A realidade, contudo, é mais dramática. O que está em jogo, na complexa ponderação aqui analisada, é o direito à vida e à saúde de uns versus o direito à vida e à saúde de outros. Não há solução juridicamente fácil nem moralmente simples nessa questão**".

Assim, ausentes os requisitos exigidos nos Temas 1234 e 6 do STF, a improcedência é medida que se impõe.

II _ DISPOSITIVO

1 _ Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão da parte autora.

2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC.

3 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 700,00, observada a gratuidade de justiça já deferida.

4 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4º, II do CPC.

5 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

6 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.

HENALDO SILVA MOREIRA
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: HENALDO SILVA MOREIRA
06/11/2025 12:47:43
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25110612474323200000232

IMPRIMIR GERAR PDF